

UNM HEALTH SCIENCES	CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE d'ALBUQUERQUE University of New Mexico Hospital - Obstetric Department
---	---

COMPTE-RENDU OPÉRATOIRE

Date de l'intervention : 14 mars 2002	Heure : 03:42 AM
Patiente : Margot YOUNG	Date de naissance : 09/09/1980 (21 ans)
Équipe : Dr. Carter (Chirurgien), Dr. Cruz (Anesth.)	N° Dossier : UNM-2002-8841

1. CONTEXTE CLINIQUE

Patiente primipare admise en urgence absolue à 26 semaines d'aménorrhée (6 mois de grossesse) pour travail prématuré spontané et métrorragies abondantes. Suspicion de décollement placentaire (HRP).

2. DÉROULEMENT DE L'ACCOUCHEMENT

L'accouchement s'est déroulé par voie basse en urgence.

- Nouveau-né** : Sexe masculin. Poids : 920g.
- État néonatal** : Score d'Apgar faible (3/5/7). Détresse respiratoire immédiate et défaillance cardiaque sévère (cardiopathie congénitale aggravée par la prématurité). Transfert immédiat en réanimation néonatale avec pronostic réservé sur le plan cardio-pulmonaire.

3. COMPLICATIONS MATERNELLES ET INTERVENTION

Immédiatement après la délivrance, la patiente a présenté une hémorragie du post-partum (HPP) massive et foudroyante, ne répondant pas aux utérotoniques.

Évènements per-opératoires :

- Instabilité hémodynamique** : Choc hémorragique sévère entraînant un premier arrêt

cardio-respiratoire (ACR) de 4 minutes. Récupération après massage cardiaque externe et injection d'adrénaline.

- **Décision chirurgicale** : Laparotomie d'urgence pour hémostase. Constat d'une atonie utérine majeure avec nécrose partielle du tissu myométrial.
- **Second arrêt cardiaque** : Nouveau collapsus durant l'intervention (durée : 2 minutes). Stabilisation difficile par transfusion massive (culots globulaires et plasma).
- **Geste technique** : Compte tenu de l'âge de la patiente (21 ans), une hystérectomie totale a été écartée pour préserver une fonction hormonale. Réalisation d'une hystérectomie subtotale reconstructrice : ablation de la moitié supérieure de l'utérus (fond et corps utérin nécrosé). Le col et la partie inférieure de l'isthme ont été conservés.

4. CONCLUSIONS ET SUITES

- **Hémostase** : Obtenue après suture et ligature des artères utérines.
- **Pronostic maternel** : Survie miraculeuse après double ACR. Patiente transférée en réanimation pour surveillance 48h.
- **Contre-indication formelle** : L'intégrité structurelle de l'utérus restant est insuffisante pour supporter une distension gravidique. **Toute nouvelle grossesse est strictement interdite** en raison d'un risque de rupture utérine létale immédiate. Une contraception définitive ou un suivi gynécologique rigoureux a été préconisé dès la sortie.

Dr. J. Carter Chirurgie Gynécologique TAMPON MÉDICAL UNM HOSPITAL ALBUQUERQUE <i>J. Carter</i>	Dr. L. Cruz Anesthésiste-Réanimateur TAMPON MÉDICAL DEPT. ANESTH. NM-40982 <i>L. Cruz</i>
--	---